



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : حسنة محمد محمود فلفل
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : البساتين
رقم البطاقة : 25911090100324 رقم التليفون : 01286263518
العنوان : البساتين - القاهرة
العمر (تاريخ الميلاد) : 09-11-1959 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 06-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حسنة محمد محمود فلما National ID: 25911090100324	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



حسبه
محمد محمود شقر
٢٧ سن علي عبدالعزير
المصريين - القاهرة

٢٠٢١/١٠/٢٤ ٢٥٩ ١١ ٠٩ ٠١ ٠٣ ٢٤

LL5380547

٢٠٢٥/١٠/٢٤ ٢٥٩ ١١ ٠٩ ٠١ ٠٣ ٢٤

رئة منزل
أنش
مستمدة
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٢/١٠/٢٤







Provisional Program for Breast Cancer
Ministry of Health and Family Welfare

البرامج المؤقتة لسرطان الثدي
وزارة الصحة والعائلة



1-Patient ID:

1- Name: حصة محمد محمود الجليل

Sex:

MDT form

3- Medical numbers:

Female

83129376

Old Med:

755/2023

2-ID numbers: 25911090100324

Patient Age: 64 Y



Family history

+VE

Phone

01114248921

BMI

Marital status

NRS Score

GROUP

REASON OF MDT

PORT

Co-morbidity

Menopausal status

Date of MDT

2023-07-28

Breast Imaging:

Clinical data

Mets Workup:

CTS PULMONARY NODULES FOR FU
BONE SCAN FREE

BX:

ER:

8/8

PR:

8/8

Her 2 Neu:

1

SISH:

KI67:

11

T

4B

N

2

M

Sonomammography

PATIENT HISTORY

PT RECEIVED 3 FEC+9WKS OF TAXOL FOR
LT MRM

MDT OUTCOME & PLAN

FOR LT MRM AS PLANNED

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

Psychiatric

RADIOLOGY

PATHOLOGY

Nutrition

Name: حسنه محمد احمد فلغل		
MR. : 5340		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحيه طبية وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
نشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient presents with a diagnosis of invasive ductal carcinoma (IDC) of the left breast, grade 2, with minimal ductal carcinoma in situ (DCIS). Immunohistochemistry shows estrogen receptor (ER) 8/8, progesterone receptor (PR) 8/8, HER2 negative, Ki-67 11%, and a T4 staging on sonomammography. The disease is described as locally advanced and multicentric. The patient has a strong family history of breast cancer. Imaging with a chest CT revealed a pulmonary nodule that is being monitored. The patient underwent left mastectomy with axillary lymph node dissection (LT MRM) in August 2023, followed by a 9-week course of FEC-T and taxol chemotherapy, and has received a radiation port and aromatase inhibitor therapy with arimidex. The patient also received supportive care for smoking cessation and has been evaluated for dental issues. The most recent attending note indicates that the patient is currently receiving arimidex for a duration of three months following a dental assessment and the initiation of zoledronic acid (zometa). The patient has completed three months of arimidex therapy to date.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	19-09-2026
	الوقت :	
	هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		

Patient Name : الأمستلاه / حمنة محمد محمود
Patient No. : 25911090100324
Path No. : 2849/23
Sex : Female
Age : 63 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001543
Request Date : 26/08/2023
Verification Date : 07/09/2023
Financial Category : مريض - مريض
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, post NACT.
Nature Specimen: Right modified radical mastectomy specimen and axillary lymph node dissection.

Gross Examination:

- * Procedure: Right MRM measured 30x26x5.5 cm with covering skin ellipse measured 30x26 cm.
- * Tumor extent: A greyish white firm tumor bed site.
- * Size: 8x7x5 cm.
- * Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly.
- * Distance from margins: 1.5 cm away from deep margin.
- * Lymph nodes number and size: 15 L.Ns up to 1cm.

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): (3+2+1) Grade II.
- Maximal tumor diameter 4 cm
- Actual tumor cellularity: 20%.
- * Ductal carcinoma in situ: present 10%
- * Skin involvement: Free
- * Lymph node involvement: 10 out of 15 positive lymph nodes
- * Resection Margins: Free deep margin
- * Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Diagnosis:

Right breast cancer post NACT, MRM and ALN dissection specimen:
Invasive duct carcinoma, Grade II

Verified by :
Dr. Hebatallah Mostafa

Printing Date : 21/04/2024 13:25:51

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss



Patient Name : الأستاذة / حسنه محمد محمود
Patient No. : 25911090100324
Path No. : 2849/23
Sex : Female
Age : 63 Y
Referring Doc :

Request No. : 13001543
Request Date : 26/08/2023
Verification Date : 07/09/2023
Financial Category : مختبر - مختبر
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

- Maximal tumor diameter: 4 cm
- Actual tumor cellularity: 20%
- Free deep margin
- Free nipple and areola
- 10/15 positive lymph nodes
- Pathologic partial response
- Stage: ypT2, ypN3
- RCB: 4.396, RCB class III.

Signature
Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr. Heba Hassan

Verified by :
Dr. Hebatallah Mostafa

Printing Date : 21/04/2024 13:25:51

Page 2 of 2

Printing By : marwa mohamed youss





Patient Name: Hosna Mohamed Mahmoud Felfel	Date : 05/01/2025
Exam : C.T CHEST	Age : 65 Year(s)
Medical ID: 755/2023	Pat. ID: 28711

NON CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Compared to 04/03/2023

- Partially scanned both breasts with interval left mastectomy.
- Regressive course of the number of the several bilateral pulmonary nodules largest currently seen at left lower lobe fissural based and measures 4 mm.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
- Bilateral elastofibroma dorsii.

Opinion:

- Regressive course of the several bilateral pulmonary micro-nodules of indeterminate nature for close follow up.

Dr. Mohamed Mohsen, M.D.



Patient Name: Hosna Mohamed Mahmoud Felfel	Date : 04/01/2025
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 65 Year(s)
Medical ID: 755/2023	Pat. ID: 28711

RIGHT BREAST MAMMOGRAPHY WITH BILATERAL US

Indication:

Patient had left MRM

Technique

- right breast MLO and CC views
- Bilateral ultrasound

Report:

- The right breast is scattered fibroglandular densities of the right breast (ACR B)
- No spiculated masses or grouped microcalcifications.
- Complementary ultrasound also showed no right breast solid or cystic masses
- Normal skin thickness and nipple-areola complex, with average caliber of the retro-areolar ducts
- Nonspecific right axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free left operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- Free left infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Left MRM with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions
- No right breast suspicious findings (BIRADS 2)

Yours truly

Signature Dr. Youmna tarek

04/01/2025 1:11 PM

جوستاف روسيه
Goustave Roussey
International Egypt

Patient's Name:

Hasna Hasna Mohammed Mahmoud Felfel

Date:

2026-08-02

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt



MULTISLICE CT EXAMINATION OF THE CHEST ,ABDOMEN AND PELVIS WITH
CONTRAST ADMINISTRATION REVEALED:-

- Evident left mastectomy with clear operative bed and no foci of recurrent/residual/newly-developed neoplastic seen herein.
- Normal right breast.
- Right axillary lymph nodes are seen with preserved their hilar fat contents and the largest one measures about 22 mm.
- Hyperinflated both lungs.
- Tiny pulmonary nodule is seen in the posterior segment of left lower pulmonary lobe and measures about 5x5mm in dimensions likely nonspecific.
- No other sizable abnormally-enhancing pulmonary nodules , patchy areas of consolidations or foci of calcifications noted.
- No sizable abnormally-enhancing mediastinal or hilar lymph nodes seen.
- Patent central airways.
- No pleural or pericardial effusions.
- Average size of the heart with normal CT of its big vessels.
- Normal bones of the thoracic cage apart from spondylo-degenerative changes of the scanned spine with degeneration of L5-S1 disc and mild spondylolisthesis of L5 over S1 vertebral body.
- Average size of the liver, measuring about 12.3cm,showing normal parenchymal attenuation and a homogenous enhancement pattern.
- No sizable abnormally-enhancing focal lesions or dilated biliary radicles.
- Patent PV.
- Average sized spleen,measuring about 11.2 cm. No focal lesions seen inside.
- Normal CT appearance of the pancreas, functioning both kidneys, both suprarenal glands, aorta and IVC.
- No sizable abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No intra-vesical stones,solid masses,wall thickening or diverticulosis seen.
- The rest of the pelvic structures are unremarkable.

IMPRESSIONS:



Patient's Name:

Hasna Hasna Mohammed Mahmoud Felfel

Date:

2026-08-02

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

- Overall stationary course

Prof/Hanan El-Ahwal.